Doutiva — Síntese estratégica

A esco

Documento para análise externa (Claude / conselho)
7 de novembro de 2026
Discussões Juliano Brites Cortes × Cursor Agent
Pós-avaliação da plataforma + benchmark Precursores do ensino com IA

1. Problema que estamos resolvendo

Médicos em prática (emagrecimento, performance, alta complexidade ambulatorial) precisam de educação médica continuada, mas:

- não gostam de *estudar* (assistir, ler, decorar);
- gostam de *aprender* (decidir, errar, corrigir, aplicar na segunda-feira);
- já sabem parte do conteúdo — empurrar curso linear gera tédio e abandono;
- precisam de proximidade (turma, mentor, eventos), não só de app;
- a escola também precisa ajudar o médico a gerar demanda no consultório (protocolo → público → agenda).

A Doutiva não pode ser “mais um LMS com IA”. Tem que ser a escola do médico do futuro: IA no centro, hábito sem dor, profundidade sob demanda, proximidade humana, e protocolo que paga a clínica.

2. Frase-mestra (para não se perder)

A IA descobre o buraco e monta a trilha. O Caso do Dia vira hábito. O protocolo aprofunda e enche a agenda. Mentoria e eventos aproximam.

Versão curta das quatro camadas:

Caso do Dia = hábito. Curso = profundidade do que falta. Mentoria + eventos = proximidade. Diagnóstico (IA) = o que ensinar.

3. Duas promessas, um sistema

Promessa | Para quem | Resultado

— Aprender sem sofrer · O médico · Só estuda o que falta; sessões curtas; domínio medido

— Protocolo que gera demanda · O consultório · Conduta padronizada → oferta clara ao paciente → agenda

Se só educar → vira curso. Se só “gerar demanda” → vira marketing. A Doutiva junta os dois: domínio clínico → conduta segura → público confia → clínica fatura.

4. Arquitetura de produto (4 peças)

4.1 Caso do Dia = o “Duolingo” clínico

- Unidade: 1 decisão / dia, 3–5 minutos.
- Canal preferencial: WhatsApp primeiro; site para aprofundar.
- Conduta + confiança declarada (`sei / acho / não sei`).

- Alimenta revisão espaçada e o mapa de domínio.
- Não é o mentor quem faz o papel de Duolingo (mentor é caro demais para hábito diário).

4.2 Universidade / Protocolos = curso de verdade

- Tratado, evidência, regulação BR (ANVISA/CFM), guia de bolso.
- Deixa de ser ementa fixa “aula 1, 2, 3…” e vira fila do que falta.
- Aprofundar sob demanda (AMBOSS-like), não parágrafo infinito.
- Oferta comercial: Protocolos R$ 297/mês (+ Peptídeos free como porta).

4.3 Mentoria = proximidade humana (produto separado)

- Turmas pequenas (8–10), mentor-guia (não palestrante).
- Encontro curto para discutir os casos mais errados da turma.
- SKU próprio na escada (não misturar com o hábito diário).

4.4 Eventos presenciais = segundo pilar de proximidade

- Semana Doutiva / A Origem / imersões.
- Marca, networking, confiança Medway-like (“quem assina”).
- Mentoria presencial + eventos = os dois principais pontos de proximidade.

---

5. A peça que faltava: ensinar só o que o médico não sabe

Hoje a plataforma ainda empurra curso e caso editorial. Os precursores de sucesso (Alpha School / MathAcademy / Khanmigo / Brilliant) fazem o oposto: diagnosticam o que já sabe e só ensinam o buraco.

5.1 Por que casos fixos sozinhos não bastam

Montar à mão milhares de casos de diagnóstico não escala e continua sendo “nossa trilha”, não “a trilha dele”.

5.2 Direção desejada: IA entrevista e monta a trilha

- IA conduz entrevista socrática (10–15 min).
- Médico responde + declara confiança.
- IA não entrega a conduta — cobra raciocínio (guarda-corpo Khanmigo).
- IA ancora no corpus Doutiva (conteúdo curado), não no ChatGPT genérico.
- Saída: mapa verde / amarelo / vermelho por tema.
- IA sugere/gera a próxima micro-sessão e o Caso do Dia a partir do buraco.
- Material permanente novo passa por assinatura humana (nome + CRM).

5.3 Regra de avanço (motor de maestria)

Resultado | Ação da plataforma

— Acertou + “sei” · Pula teoria daquele tema

— Acertou + “acho” · Caso gêmeo leve; domínio parcial

— Errou ou “não sei” · Sessão curta só do buraco → reteste

— 3 casos não vistos corretos + confiantes · Tema = dominado

O Índice de Domínio substitui “aula concluída” em painel, certificado e ranking.

---

6. A IA no centro (cérebro único, três faces)

Não é um botão “Tutor” no canto. É o sistema nervoso da escola.

Face | Função | Entrada → Saída

— Cartógrafo · Entende o médico · Conversa + confiança → mapa de domínio

— Preceptor · Ensina o buraco · Mapa → Caso do Dia / sessão socrática

— Estúdio · Transforma material em aula · PDF/diretriz/monografia → lâminas, casos, guia, áudio (médico assina)

Requisitos para resultado de alto nível

- Memória longa do médico (mastery persistido).
- RAG / corpus Doutiva — só gera e ensina ancorado no material revisado.
- Motor de decisão — atualiza mapa → escolhe próxima sessão → agenda revisão.
- Guarda-corpo pedagógico — socrático; nunca entrega conduta antes do compromisso.
- Humano na vitrine — IA na cozinha; CRM/nome na assinatura; mentor/evento na proximidade.
- Métricas de verdade — delta de domínio, sessões/semana, retenção D30, NPS (não “horas publicadas”).

Arquitetura lógica

```
Materiais curados → Corpus Doutiva (versionado + assinado)
                          |
Médico ← conversa →  CÉREBRO DOUTIVA  → mapa / fila / Caso do Dia
                          |
                    Estúdio gera aula
                          |
                  Médico revisor assina
```

No produto: Professores, Tutor, Caso do Dia, onboarding “Mapa” e Estúdio chamam o mesmo cérebro (mesmas tools: getMastery, updateMastery, nextSession, retrieveCorpus, generateLessonDraft).

---

7. O que já existe vs. o que falta

Já existe (não jogar fora)

- Loop lâminas → chaves → caso → revisão
- 7 trilhas / conteúdo clínico denso
- Professores de IA (personas) + Tutor
- Revisão espaçada
- Protocolos R$ 297 alinhado na oferta
- Intensidade Completa / Equilibrada / Discreta
- Sprint recente: monografias legíveis, leaks, auto-matrícula, tabs Aprofundar

Falta (o salto)

- IA ligada em produção (env Vercel)
- Entrevista/Mapa clínico como porta de entrada
- Caso do Dia dirigido pelo mapa (não por calendário fixo)
- Índice de Domínio por tema
- WhatsApp como canal do hábito
- Docente com nome/CRM/foto na vitrine

- Mentor + eventos usando o mapa da turma
- Elo explícito “tema dominado → oferta ao paciente / demanda”

---

8. Plano em fases (ordem prática)

Fase A — Ligar a base (esta semana)

- `OPENAI_API_KEY` (+ Supabase service role) na Vercel + redeploy
- Conta aluno de QA (sem admin)
- Docente real no “Revisado por”
- Limpar fixtures de teste

Fase B — Cérebro + hábito (diferencial)

- Serviço único Cérebro Doutiva
- Fluxo Mapa clínico (entrevista IA → mastery_by_topic)
- Caso do Dia lê a fila do mapa + confiança
- WhatsApp do Caso do Dia (piloto 50)

Fase C — Protocolo que paga a clínica

- Cada tema dominado desbloqueia Guia de bolso + oferta ao paciente
- Universidade vira fila do que falta (Aula 2.0: caso primeiro)

Fase D — Proximidade

- Mentoria presencial com pauta = lacunas da turma
- Eventos (A Origem / Semana) sobre a base ativa

Portões sugeridos

- Semana 2 do piloto: ≥70% fazem 3 sessões
- D30: retenção > 60%
- Domínio médio +20 pts vs baseline
- NPS > 60 antes de escalar aquisição paga

---

9. Escada comercial (sem confundir SKUs)

Oferta | O que entrega

— Peptídeos (grátis) · Porta de entrada + hábito light

— Protocolos (R$ 297/mês) · Mapa + Caso do Dia + Universidade + Preceptor

— Mentoria · Proximidade humana / turma

— Imersão / Eventos · Proximidade presencial + marca

— Clube · Círculo restrito / conselho

IA e hábito vivem em Protocolos. Mentoria e eventos continuam produtos separados de proximidade.

---

10. O que NÃO fazer

- Chatbot aberto sem corpus Doutiva (“cheatbot”)
- Empurrar ementa linear para quem já domina o tema
- Fazer o mentor virar Duolingo

- Fundir mentoria dentro do curso e perder o SKU
- Medir sucesso por aulas concluídas / horas publicadas
- Abrir para médico pagante sem Mapa + IA ligada + proximidade mínima no piloto

---

11. Pedido de análise ao Claude

Por favor, avalie criticamente:

- A arquitetura Caso do Dia / Curso / Mentoria+Eventos / Mapa-IA está coerente para EMC de médicos em prática no Brasil?
- O desenho do cérebro único (Cartógrafo / Preceptor / Estúdio) é suficiente para "IA no centro", ou falta alguma camada (ex.: voz, multiagente de auditoria, CRM clínico)?
- Como priorizar as Fases A–D se o objetivo é: (a) retenção, (b) gerar demanda para o consultório, (c) proximidade de comunidade?
- Quais riscos regulatórios/éticos (CFM, propaganda de procedimento, responsabilidade do conteúdo gerado por IA) precisam de guarda-corpo explícito?
- Proponha um MVP de 30 dias ainda mais enxuto, se discordar da ordem acima.
- Sugira métricas de piloto e critério de "go / no-go" para abrir Protocolos com a nova promessa.

---

12. Referências internas desta conversa

- Avaliação da plataforma (06/11/2026)
- Benchmark *Precursores do ensino com IA no mundo* (07/11/2026) — Alpha, Khanmigo, Duolingo, Brilliant, AMBOSS/NEJM Knowledge+, Arist/WhatsApp
- Plano 90 dias: `docs/plano-tutor-maestria-90-dias.md`
- Norte de cópia: AMBOSS (produto) × Medway (confiança) × MasterClass (marca) × Duolingo (hábito)

Fim da síntese. Documento preparado para revisão crítica e refinamento do plano de execução.